EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	Nº EGRESO	:	87560
SERVICIO	:	MEDICINA HSC			
FECHA	:	2024-06-28 17:20:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: HECTOR RAMON PARADA DURAN			RUN	: 8.521.738-0
F.Nac	: 17-09-1957	Edad	: 66 AÑOS, 9 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: PAQUE NORTE CURICA 91037111			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 957143714		
Fecha Ingreso	: 2024-06-25	Fecha Egreso	: 2024-06-28 17:20:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J96.9-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

INSUF RESP AGUDA POR NEUMONIA VIRAL (INFLUENZA A + OBS SOBREINFECCION BACTERIANA)
EPOC EXACERBADO
ENFISEMA PULMONAR
ANTEC : ERC EN HD, HTA, DM2, HPB, USUARIO CUP, TABAQUISMO ACTIVO, ARTROSIS,

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J10.0-INFLUENZA CON NEUMONIA, DEBIDA A VIRUS DE LA INFLUEZA ESTACI (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE CON ANTECEDENTES DE EPOC GOLD D Y TABAQUISMO ACTIVO , ERC EN HEMODIALISIS DESDE ABRIL 2024 QUIEN INICIA CLINICA EL 6/6/2024 CARACTERIZADO POR TOS,MIALGIAS Y DISNEA DE 3 DIAS DE EVOLUCION EN TRATAMIENTO AMBULATORIO INDICADO EN APS CON AMOXICILINA SIN EMBARGO ES DERIVADO A HSC DONDE INGRESA EN CONTEXTO DE NEUMONIA. EXAMENS DE INGRESO CON TEST PARA INFLUENZA A Y B NEGATIVOS, MANTENIENDOSE CON REQUERIMIENTOS DE FIO2, POSTERIORMENTE DURANTE HOSPITALIZACION SE RECIBE PANEL VIRAL RESPIRATORIO + INFLUENZA A. POSTERIORMENTE PACIENTE PRESENTA ALTERACION DE LA MECANICA VENTILATORIA CON SIGNOLOGIA DE OBSTRUCCION BRONQUIAL CON MUY ESCASA RESPUESTA A BRONCODILATACION PORLO QUE SE PROCEDE A MANEJO DE VIA AEREA Y TRASLADO A HHM A UPC POR REQUERIMIENTO DE HVVC. PACIENTE ES EXTUBADO EL 15/06/24 CON SALIDA A VMNI HASTA EL 23/6 QUE SE LOGRA VENTANAS Y SE TITULA A NRC, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE POR LO QUE SE GESTIONA RESCATE A HOSPITAL DE ORIGEN PARA CONTINUAR SEGUIMIENTO.
AL RETORNO EN SALA HSC, REGULARES CONDICIONES GENERALES DADAS POR APREMIO VENTILATORIO, QUE LUEGO VA CEDIENDO, ADEMAS SE DESTETA DE O2 AYER EN LA MAÑANA, TOLERANDO OK FIO2 AMBIENTAL. RETORNA DE HEMODIALISIS, CON RUIDOS BRONQUIALES HUMEDOS ESCASOS, PERO SATURACION OK (97% AMB)
LABORATORIO HOY PARAMETROS INFLAMATORIOS BAJOS (PCR 20, LEUCO 10800), PCTE EN MEJORES CONDICIONES GENERALES, PEREO NO PARA ALTA A DOMICILIO POR REQUERIMIENTO DE KINESITERAPIA, POR LO QUE SE SOLICITARA HODOM.

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO RELATIVO ASISTIDO, SEMISENTADO
2. REGIMEN LIVIANO DIABETICO HIPOSODICO/ RESTRICCION HIDRICA 1000CC/DIA
3. KNT RESPIRATORIA Y MOTORA x 2
4. H-DIALISIS EN CENTRO DE CRONICOS 3 VECES SEMANA
5. BROMURO IPATROPIO 4 PUFF C/6H
6. SALMETEROL FLUTICASONA 2 PUFF C/12H
7. SALBUTAMOL 4 PUFF C/6H
8. OMEPRAZOL 20MG 1 AL DIA VO
9. PARACETAMOL 500MG 2 C/8HRS SOS SI DOLOR O FIEBRE
10. CARVEDILOL 6,25MG ½ C/12 HRS VO
11. RESTO TRATAMIENTOS CRONICOS RETOMAR Y MANTENER
12. CONTROL POST ALTA DE HODOM EN 20 A 30 DIAS CAE MEDICINA HSC
13. CONTROL SOS VIA URGENCIA

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO